

REPETITOIRE EXAMEN FEDERAL

5 VIGNETTES

THEME : PHARYNGO-LARYNX

Dr Valérie Schweizer, médecin adjointe, Service d'ORL, CHUV
valerie.schweizer@chuv.ch

Objectifs de cours

- Connaissance de l'anatomo-physiologie et des principales pathologies du carrefour aéro-digestif pharyngo-laryngé, en particulier les troubles de la déglutition et de la phonation.
- Connaissance des signes et symptômes propres à cette région et des moyens d'investigations à disposition.

CQT	91 à 104
CPE	199 à 201

Plan du cours

- 1) Anatomie du pharyngo-larynx
- 2) La voix et la phonation
- 3) Signes et symptômes laryngés : toux, dyspnée (stridor), dysphonie
- 4) Moyens d'investigations du larynx
- 5) Principales affections laryngées: inflammation, troubles fonctionnels, lésions bénignes, tumeurs.
- 6) Innervation du pharyngo-larynx
- 7) La déglutition physiologique
- 8) Moyens d'investigation du pharynx et de la déglutition
- 9) Paralysies pharyngo-laryngées
- 10) Dysphagie

VIGNETTE 1

Un patient de 80 ans vous consulte car lorsqu'il mange des aliments solides, ceux-ci restent parfois bloqués transitoirement dans son pharynx; il doit boire pour finir de les déglutir. Parfois, en fin de repas ou après le repas, il doit recracher une petite quantité d'aliments « qui remontent » dans sa gorge. Il n'a pas de douleurs.

Quelles questions complémentaires lui posez-vous ?

Anamnèse d'une dysphagie

- Depuis quand ?
- A chaque repas ? Occasionnellement ? En mangeant ou buvant quoi ? Et la salive ?
- Est-ce que cela fait mal ? Où ? Otagie réflexe ?
- Dysphagie aux solides : blocages; où ? bouche ? pharynx ? oesophage ?
- Régurgitations ? Vomissements ?
- Dysphagie aux liquides : fausses routes, toux pendant ou après les repas. Systématique ?
- Toux en mangeant ?
- Infections pulmonaires ? Fièvre ?
- Avez-vous perdu du poids ? Combien ?

Dysphagie – recherche étiologique

- Dysphagie **douloureuse**
- Dysphagie **mécanique**
- Dysphagie **neurologique**
- Dysphagie **psychogène**

Dans quelle catégorie de « dysphagie » le classez-vous ?

Dysphagie – recherche étiologique

- Dysphagie **douloureuse**
- Dysphagie **mécanique**
- Dysphagie **neurologique**
- Dysphagie **psychogène**

VIGNETTE 1

Un patient vous consulte en raison de régurgitations alimentaires survenant quotidiennement pendant ou après les repas, sans odynophagie ni nausées. La régurgitation d'aliments est un symptôme cardinal de :

- (A) mycose pharyngo-oesophagienne
- (B) paralysie unilatérale du nerf X (vague)
- (C) diverticule de Zenker
- (D) tumeur du sinus piriforme
- (E) épiglottite

VIGNETTE 1

Un patient vous consulte en raison de régurgitations alimentaires survenant quotidiennement pendant ou après les repas, sans odynophagie ni nausées. La régurgitation d'aliments est un symptôme cardinal de :

- (A) mycose pharyngo-oesophagienne
- (B) paralysie unilatérale du nerf X (vague)
- (C) **diverticule de Zenker**
- (D) tumeur du sinus piriforme
- (E) épiglottite

VIGNETTE 1

Un patient vous consulte en raison de régurgitations alimentaires survenant quotidiennement pendant ou après les repas, sans odynophagie ni nausées. La régurgitation d'aliments est un symptôme de :

- (A) tumeur sténosante de l'œsophage ?
- (B) paralysie unilatérale du nerf X (vague)
- (C) diverticule de Zenker ?
- (D) tumeur du sinus piriforme
- (E) épiglottite

VIGNETTE 1 (suite)

Un patient vous consulte en raison de régurgitations alimentaires survenant quotidiennement, sans odynophagie ni nausées. La régurgitation d'aliments est un symptôme de :

- (A) tumeur sténosante de l'œsophage ?
- (B) paralysie unilatérale du nerf X (vague)
- (C) diverticule de Zenker ?
- (D) paralysie du nerf grand hypoglosse
- (E) épiglottite

Réponse A et C....

Quel(s) examen(s) complémentaire(s)

VIGNETTE 1 (suite)

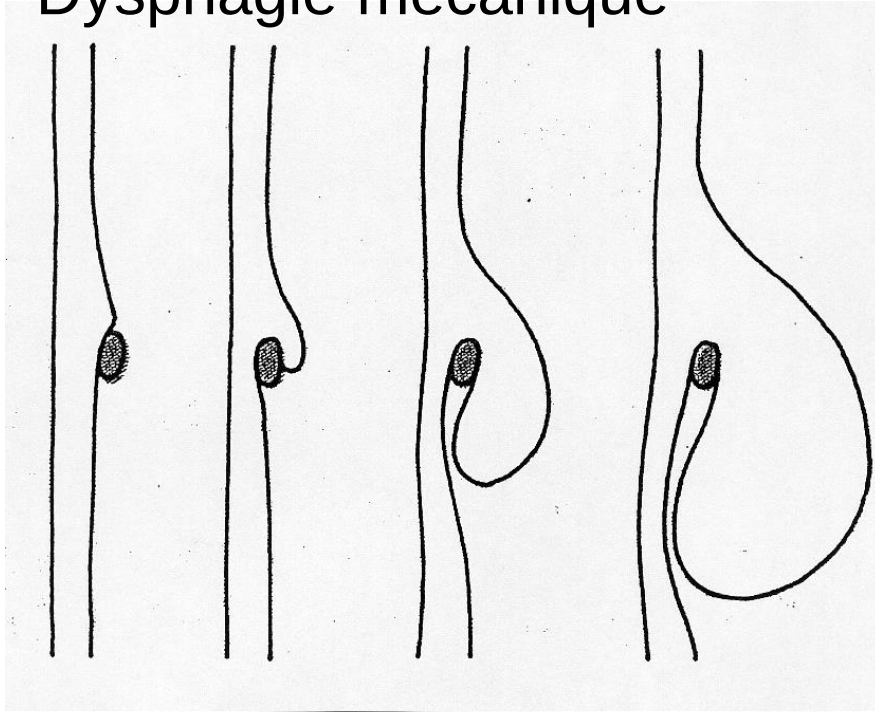
Un patient vous consulte en raison de régurgitations alimentaires survenant quotidiennement, sans odynophagie ni nausées. La régurgitation d'aliments est un symptôme de :

- (A) tumeur sténosante de l'œsophage ?
- (B) paralysie unilatérale du nerf X (vague)
- (C) diverticule de Zenker ?
- (D) paralysie du nerf grand hypoglosse
- (E) épiglottite

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) :

- TRANSIT RADIOLOGIQUE DE LA DEGLUTITION
- Selon résultat : CTScan cou-thorax et/ou endoscopie pharyngo-oesophagienne

Dysphagie mécanique

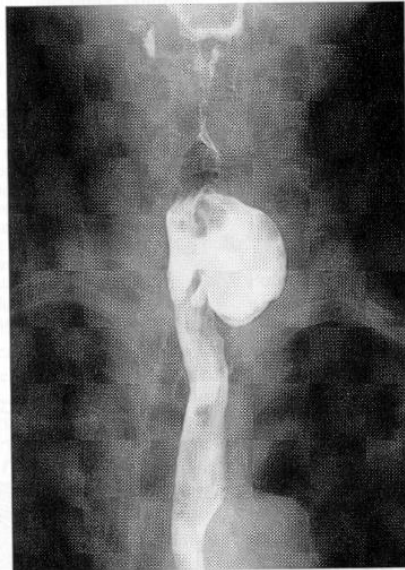


Diverticule de Zenker



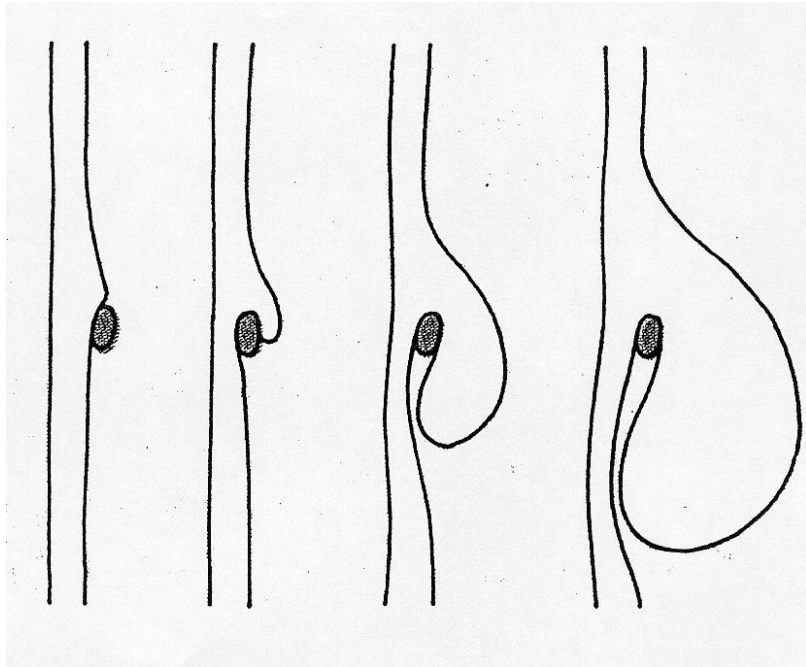
Symptômes :

- gêne hypopharyngée
- sensation de corps étranger
- régurgitations post-prandiales
- pneumonies d'aspiration



Examen
radiologique
transit baryté
(vidéofluoroscopie)

Dysphagie mécanique



Diverticule de Zenker

Etiologie :

- hypertonie crico-pharyngée :
blocages alimentaires
hypopharyngés
- initial : reflux gastro-oesophagien
- c'est un diverticule pharyngé,
de pulsion
- population : personnes âgées

Traitements :

- injection crico-pharyngée de toxine botulique (transitoire)
- myotomie et marsupialisation par voie endoscopique
- myotomie crico-pharyngée et suspension du diverticule
par cervicotomie gauche. **Pourquoi « gauche » ?**

Le nerf laryngé récurrent gauche a un trajet médiastinal; il est ainsi plus à risque d'être atteint durant la vie du patient et toute opération cervico-médiastinale risque de le léser et de le paralyser. On préfère ainsi risquer une atteinte opératoire gauche.

VIGNETTE 2

Une patiente de 31 ans a subi il y a trois semaines une thyroïdectomie totale pour un goître bénin multinodulaire. Elle vous consulte car elle trouve sa voix faible, voilée. Elle n'arrive pas à parler d'une voix forte (la voix se casse). Elle n'a pas de douleurs.

Quelles questions complémentaires lui posez-vous ?

Anamnèse d'une dysphonie

- Depuis quand ? Comment votre voix était-elle avant ?
- La voix a-t-elle changé brusquement ?
Progressivement ?
- Est-ce qu'elle redevient normale par moment ?
- Avez-vous mal ? Où ? Otalgie réflexe ?
- Avez-vous de la peine à déglutir ? Des fausses routes ?
- Toussez-vous en mangeant ? En buvant ?
- Avez-vous plus de peine à respirer ?
- Quel métier faites-vous ? Devez-vous souvent parler au quotidien ?

Dysphonie – recherche étiologique

- Dysphonie **inflammatoire, infectieuse**
- Dysphonie **mécanique**, par lésion cordale
- Dysphonie **neurologique**
- Dysphonie **fonctionnelle**
- Dysphonie **psychogène**

VIGNETTE 2

Une patiente de 31 ans a subi il y a trois semaines une thyroïdectomie totale pour un goître bénin multinodulaire. Depuis, elle trouve sa voix faible, voilée. Elle n'arrive pas à parler d'une voix forte (la voix se casse). Elle n'a pas de douleurs.

Parmi les 5 diagnostics suivants, lequel est le plus probable?

- (A) laryngite aiguë
- (B) nodules des cordes vocales
- (C) hématome cordal
- (D) paralysie hémilaryngée
- (E) oedème de Reinke

VIGNETTE 2

Une patiente de 31 ans a subi il y a trois semaines une thyroïdectomie totale pour un goître bénin multinodulaire. Depuis, elle trouve sa voix faible, voilée. Elle n'arrive pas à parler d'une voix forte (la voix se casse). Elle n'a pas de douleurs.

Parmi les 5 diagnostics suivants, lequel est le plus probable ?

- (A) laryngite aiguë
- (B) nodules des cordes vocales
- (C) hématome cordal
- (D) paralysie hémilaryngée
- (E) oedème de Reinke

VIGNETTE 2

Parmi les causes suivantes, lesquelles peuvent être à l'origine d'une paralysie cordale ? Plusieurs réponses possibles.

- (A) opération cervicale
- (B) névrite d'un nerf laryngé récurrent
- (C) tumeur maligne de la thyroïde
- (D) carcinome du tiers supérieur de l'œsophage
- (E) œdème de Reinke

VIGNETTE 2

Parmi les causes suivantes, lesquelles peuvent être à l'origine d'une paralysie cordale ? Plusieurs réponses possibles.

- (A) **opération cervicale** ?
- (B) **névrite** d'un nerf laryngé récurrent
- (C) **tumeur maligne de la thyroïde**
- (D) **carcinome du tiers supérieur de l'œsophage**
- (E) œdème de Reinke

Réponses : A, B, C, D

Innervation pharyngo-laryngée

- Noyau ambigu (tronc)
- Nerf vague
- Plexus pharyngé (+ IX)
- Nerf laryngé supérieur
+ nerf laryngé externe
- Nerf laryngé inférieur = nerf laryngé récurrent

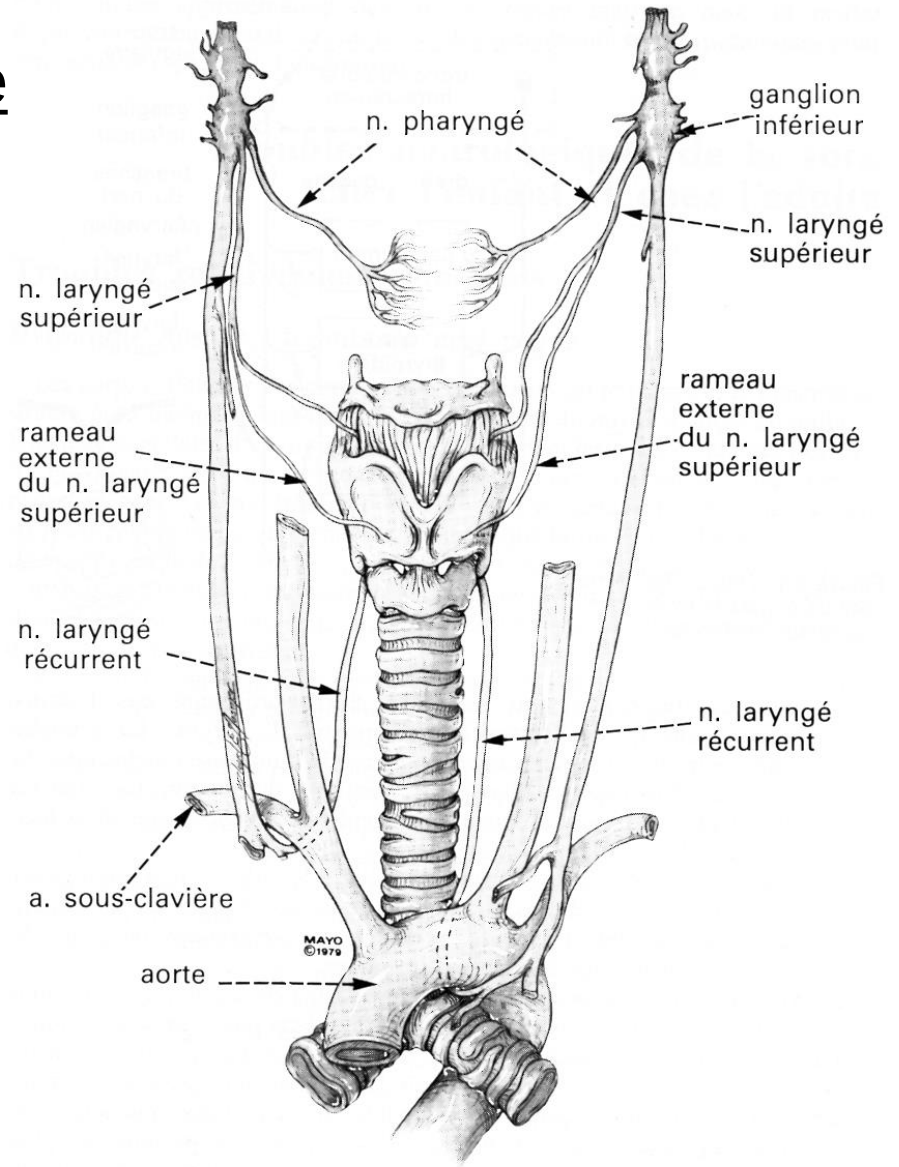


Figure 5-2. Trajets asymétriques des nerfs laryngés récurrents droit et gauche.

(Aronson, "Les troubles cliniques de la voix")

VIGNETTE 2

Une patiente de 31 ans a subi il y a trois semaines une thyroïdectomie totale pour un goître bénin multinodulaire. Depuis, elle trouve sa voix faible, voilée. Elle n'arrive pas à parler d'une voix forte (la voix se casse). Elle n'a pas de douleurs.

Quelles investigations complémentaires en cas de paralysie laryngée unilatérale ?

VIGNETTE 2

Une patiente de 31 ans a subi il y a trois semaines une thyroïdectomie totale pour un goître bénin multinodulaire. Depuis, elle trouve sa voix faible, voilée. Elle n'arrive pas à parler d'une voix forte (la voix se casse). Elle n'a pas de douleurs.

Quelles investigations complémentaires ?

- Palpation cervicale
- Examen bouche / pharynx / larynx : aspect, mobilité
- Si la cause n'est pas évidente : CTScan cervico-thoracique +/- IRM cérébrale et base du crâne (si suspicion d'atteinte d'un nerf vague)
- Sans cause objectivable : sérologie Lyme, HIV.

VIGNETTE 3

Un homme de 35 ans vient vous demander conseil. Il refait du vélo depuis peu et s'est senti très essoufflé, avec peine à respirer et bruits respiratoires importants lors d'une montée d'un col. Sa voix est très enrouée, mais il en a l'habitude; elle l'est depuis plusieurs années.

Quelles questions complémentaires lui posez-vous ?

DYSPNEE



- **Définition** : difficulté respiratoire (sensation subjective de manque d'air) ressentie à l'inspiration ou à l'expiration, ou aux deux temps de la respiration. Perception anormale et désagréable de la respiration (sensation de gêne)

- **Anamnèse d'une dyspnée « haute »** :

Depuis quand ? Comment est-elle apparue ?

A quel(s) moment(s) ? constante ? à l'effort ? en parlant ? en mangeant ?

Lors de quelle(s) activité(s) ?

Autres symptômes (douleur, otalgie réflexe, gêne ou bruit respiratoire, peine à déglutir) ?

Allergies connues ? Antécédents d'asthme ? Autres antécédents (intubation, accident, épisodes similaires...)

Votre voix a-t-elle changé ?

Dyspnée – Quel(s) **BRUIT(S)** associés ?

- laryngée
stridor inspiratoire (« cornage »)
œdème laryngé, épiglottite
diplégie laryngée
laryngomalacie (margelle larynx trop souple)
troubles fonctionnels
- obstacle sous-glottique
stridor inspiratoire, légèrement expiratoire
faux-croup / oedème sous-glottique
hypoplasie cricoïdienne
- obstacle trachéal haut
stridor aux 2 temps
corps étranger trachéal
trachéomalacie, sténose trachéale
- intra-thoracique/bronchique
expirium prolongé
asthme, emphysème, bronchiolite
sténose bronchique tumorale, cicatricielle

VIGNETTE 3

Un homme de 35 ans vient vous demander conseil. Il refait du vélo depuis peu et s'est senti très essoufflé, avec peine à respirer et bruits respiratoires importants lors d'une montée d'un col. Sa voix est très enrouée, mais il en a l'habitude; elle l'est depuis longtemps.

A quels diagnostics pensez-vous ? Plusieurs réponses possibles.

- (A) oedème de Reinke
- (B) cancer du larynx
- (C) épiglottite
- (D) papillomatose laryngée
- (E) asthme d'effort

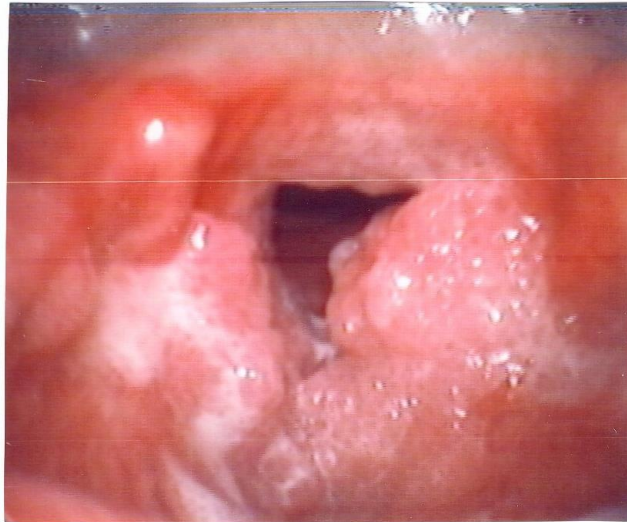
VIGNETTE 3

Un homme de 35 ans vient vous demander conseil. Il refait du vélo depuis peu et s'est senti très essoufflé, avec peine à respirer et bruit respiratoire important lors d'une montée d'un col. Sa voix est très enrouée, mais il en a l'habitude; elle l'est depuis longtemps. A quels diagnostics pensez-vous ? Plusieurs réponses possibles.

- (A) oedème de Reinke
- (B) cancer du larynx
- (C) épiglottite
- (D) papillomatose
- (E) asthme d'effort

(NB: un asthme ne s'accompagne pas souvent d'une dysphonie chronique)

VIGNETTE 3 Examen laryngé



Diagnostic ?

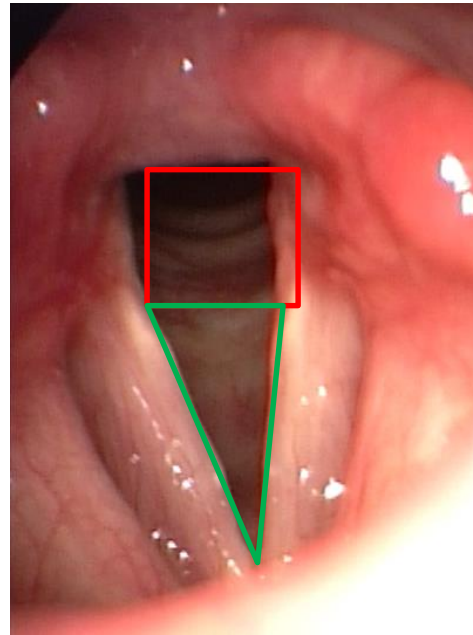
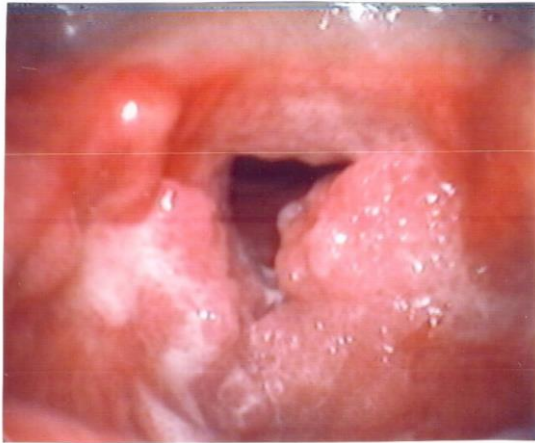
Pourquoi le patient est-il dyspnéique ?

Pensez-vous que la dysphonie soit sévère ?

VIGNETTE 3

Examen laryngé

LA GLOTTE = espace délimité par les cordes vocales



-  Glotte cartilagineuse
= respiratoire
-  Glotte membraneuse
= vocale

Diagnostic : papillomatose laryngée

Pourquoi est-il dyspnéique ? Car les papillomes commencent à obstruer l'espace glottique «respiratoire», postérieur

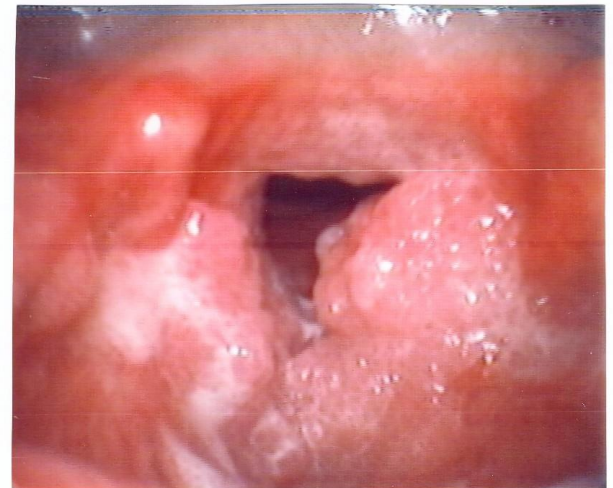
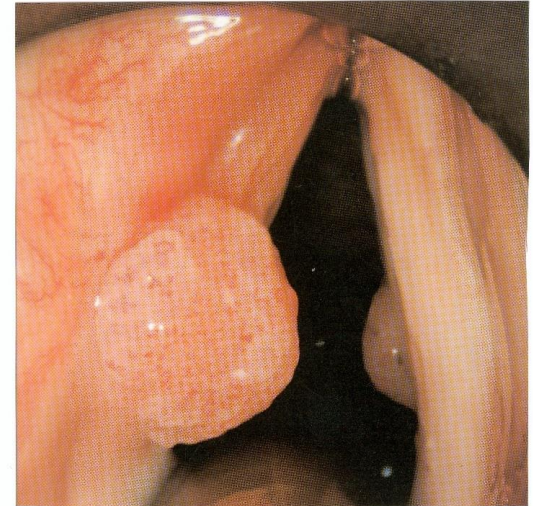
Pensez-vous que la dysphonie soit sévère ? Oui, sa voix est très rauque et désonorisée; il n'y a plus de vibrations cordales possibles.

Papillomatose laryngée

- Deuxième cause la plus fréquente de dysphonie de l'enfant.
- Evolution imprévisible.
- Etiologie : **virus HPV-6 et HPV-11**.
- Incidence : ~ 4.3 / 100'000.
- Facteurs aggravants :
 âge < 3 ans / HPV-11
 extension trachéale
- Forme adulte moins agressive, mais tout aussi difficile à éradiquer. Peut se Cancériser.

Toute dysphonie progressive chez l'enfant motive un examen sous narcose si la laryngoscopie simple n'est pas réalisable !!!

PAPILLOMES LARYNGES

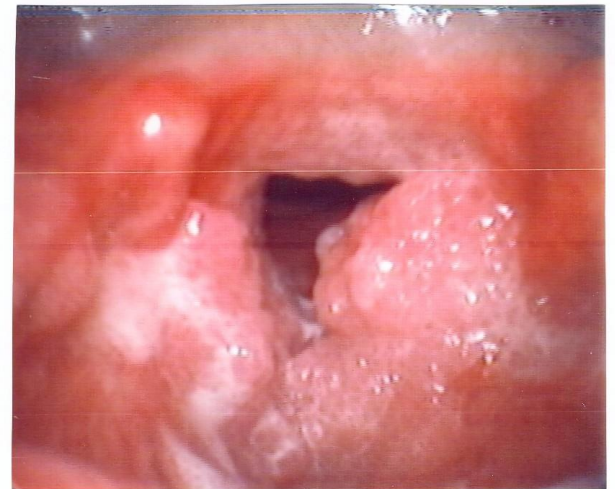
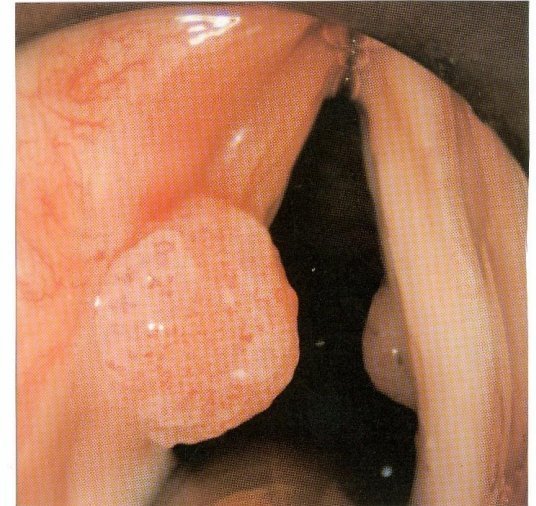


Papillomatose laryngée

Traitements :

- Exérèse microchirurgicale itérative
- Injections intralaryngées de cidofovir (antiviral utilisé dans le traitement de pneumonies HIV)
- Non contagieux (pas de preuve formelle)
- Critère opératoire une fois le diagnostic posé :
 - Gêne vocale
 - Gêne respiratoire

PAPILLOMES LARYNGES



VIGNETTE 4

Homme, 63 ans (FG)

Plainte : dysphonie lentement progressive depuis un an, sans douleur, ni dyspnée, ni dysphagie.

Directeur de travaux; sportif (triathlon).

Asthme d'effort traité par Seretide 2x/j (5 ans)

Polypose naso-sinusienne traitée par Fuorate de mométasone; pas d'allergie.

Pas de tabac

Apnées du sommeil non appareillées.

Quels examens réalisez-vous ?

VIGNETTE 4

Homme, 63 ans (FG)

Plainte : dysphonie lentement progressive depuis un an, sans douleur, ni dyspnée, ni dysphagie.

Directeur de travaux; sportif (triathlon).

Asthme d'effort traité par Seretide 2x/j (5 ans)

Polypose naso-sinusienne traitée par Fuorate de mométasone; pas d'allergie.

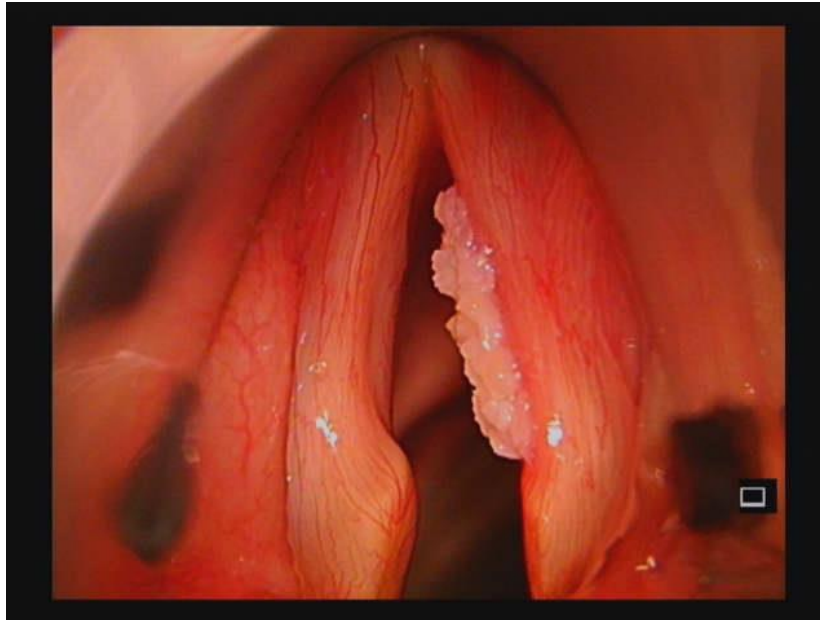
Pas de tabac

Apnées du sommeil non appareillées.

Quels examens réalisez-vous ? Examen laryngé

VIGNETTE 4

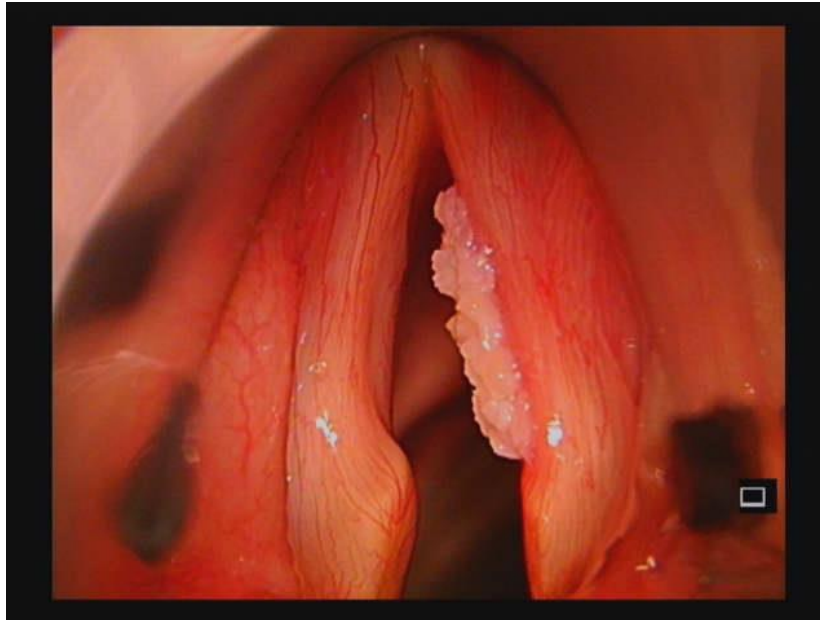
Homme, 63 ans (FG) Examen laryngé



Que faites-vous en voyant cette image ?
Médicament ? Radiologie ? Opération ?

VIGNETTE 4

Homme, 63 ans (FG) Examen laryngé



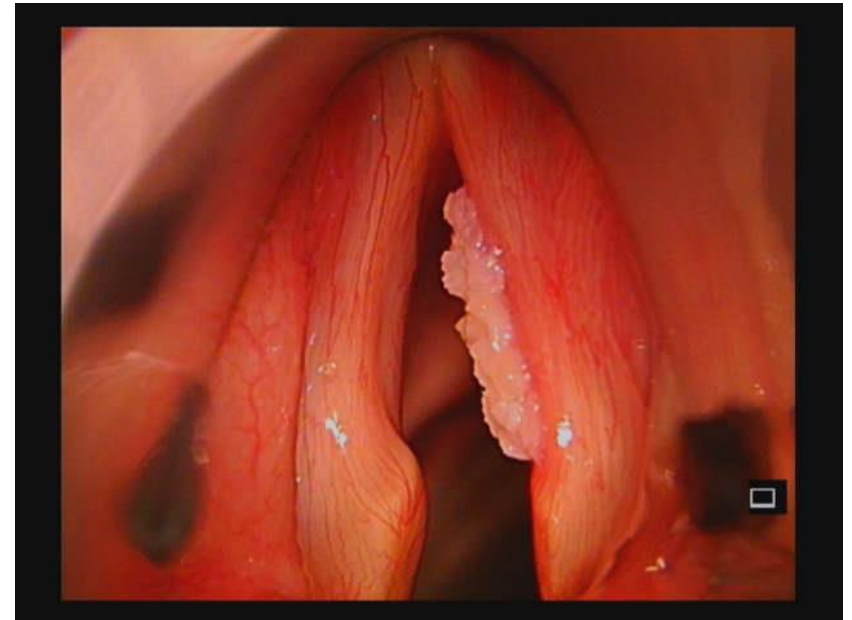
Que faites-vous en voyant cette image ?

Microlaryngoscopie en suspension et
biopsie-exérèse de la lésion

VIGNETTE 4

Un patient de 63 ans vous consulte en raison d'une voix devenue progressivement rauque et moins sonore en une année, sans dyspnée ni odynodysphagie. Examen laryngé : cf photo. Parmi les suivants, quel est le diagnostic le plus probable ?

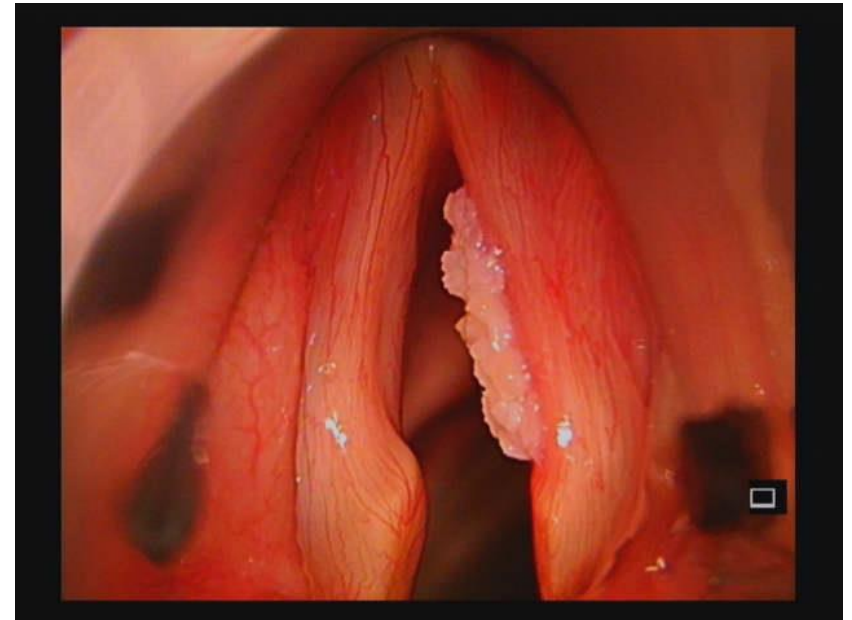
- (A) oedème de Reinke
- (B) tuberculose laryngée
- (C) mycose laryngée
- (D) carcinome épidermoïde
- (E) polype cordal



VIGNETTE 4

Un patient de 63 ans vous consulte en raison d'une voix devenue progressivement rauque et moins sonore en une année, sans dyspnée ni odynodysphagie. Examen laryngé : cf photo. Parmi les suivants, quel est le diagnostic le plus probable ?

- (A) oedème de Reinke
- (B) tuberculose laryngée
- (C) mycose laryngée
- (D) **carcinome épidermoïde**
- (E) polype cordal



VIGNETTE 5

Un patient de 45 ans vous consulte en raison d'une voix devenue progressivement rauque et grave, sans dyspnée ni odynodysphagie. Au status laryngé, vous observez une tuméfaction oedémateuse bilatérale de ses cordes vocales. Cet aspect est typique de :

- (A) oedème de Reinke
- (B) amyloïdose laryngée
- (C) épiglottite
- (D) faux croup
- (E) tuberculose laryngée

VIGNETTE 5

Un patient vous consulte en raison d'une voix devenue progressivement rauque et grave, sans dyspnée ni odynodysphagie. Au status laryngé, vous observez une tuméfaction oedémateuse bilatérale de ses cordes vocales. Cet aspect est typique de :

- **(A) oedème de Reinke**
- (B) amyloïdose laryngée
- (C) épiglottite
- (D) faux croup
- (E) tuberculose laryngée

Œdème de Reinke (tabagisme)

Voix rauque et grave.

S'accroît progressivement : risque lent de dyspnée obstructive. **Type de stridor ?**
inspiratoire

Bénin au stade « transparent », souple.
Peut se transformer en laryngite chronique hyperplasique (pachydermie laryngée).

Causes :

Tabac et forçage vocal.

Traitement :

Sevrage tabagique.

Rééducation vocale.

Cure microchirurgicale (MLS) et thérapie logopédique.

Cave : récurrence si tabac !!



EPIGLOTTITE (aspect typique)

